



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 01 — Síndrome Coronariana Aguda (SCA) e Infarto Agudo do Miocárdio

IAM com supradesnível de ST (IAMCSST), IAM sem supra (IAMSSST) e angina instável — cenário: pronto-socorro sem hemodinâmica e sem UTI própria

Código	PS-ND-01	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Este protocolo orienta o médico plantonista do PS Natal Diegues no reconhecimento, estabilização, reperfusão farmacológica (quando indicada) e regulação do paciente com SCA. O serviço **não dispõe de hemodinâmica nem de UTI própria**; portanto a decisão central no IAMCSST é **temporal**: transferir para angioplastia primária se alcançável em até 120 minutos, ou fibrinolisar localmente e transferir em estratégia farmaco-invasiva.

Fontes de ancoragem: V Diretriz SBC de IAMCSST (Arq Bras Cardiol 2015;105(2 Supl.1)); Diretriz SBC de Angina Instável e IAMSSST 2021 (Arq Bras Cardiol 2021;117(1):181-264); Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250620); Linha de Cuidado do IAM — Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 3.438/2021; Portarias de Consolidação nº 3 e 6/2017); ACC/AHA 2025 e ESC 2023 (comparação). Não há diretriz brasileira específica de IAMCSST posterior a 2015: onde a V Diretriz é anterior às evidências mais recentes, o texto sinaliza a atualização (oxigênio, morfina, dose de tenecteplase no idoso).

Convenção de confiança: doses e tempos-limite marcados com **[VERIFICAR]** devem ser conferidos na bula/diretriz vigente antes da aprovação institucional. Nada neste documento substitui o julgamento clínico à beira-leito.

1. Queixa — o que o paciente refere

Desconforto torácico retroesternal ou precordial em **aperto, peso, opressão ou queimação**, tipicamente com duração superior a 10–20 minutos, com irradiação para membros superiores (mais à esquerda), pescoço, mandíbula, dorso ou epigástrio, frequentemente acompanhado de sudorese fria, náusea e dispneia. O paciente pode descrever "sensação de morte iminente", "peso no peito" ou "má digestão que não passa".

Gatilhos para abrir o protocolo de dor torácica (Diretriz SBC Dor Torácica 2025)

- Qualquer dor **vigente na admissão** localizada entre a cicatriz umbilical e a mandíbula;
- Qualquer dor torácica que **tenha durado mais de 10 minutos**, ainda que ausente na chegada;
- Equivalentes anginosos em populações de apresentação atípica (abaixo).

Apresentações atípicas — 10 a 30% das SCA não se apresentam como dor torácica

Dispneia isolada, epigastralgia, náusea/vômito, síncope ou pré-síncope, fadiga inexplicada, confusão aguda no idoso, sudorese sem dor. Grupos de risco para apresentação atípica: **idosos, mulheres, diabéticos, doença renal crônica**. Regra prática: em diabético ou idoso com mal-estar inexplicado, faça o ECG.

2. Clínica — sinais e sintomas, estratificação e diferenciais

2.1 Classificação de Killip-Kimball (Am J Cardiol 1967;20:457-464)

Classe	Achado	Mortalidade na série original	Implicação prática
I	Sem sinais de insuficiência cardíaca	6%	Manejo padrão
II	Estertores até metade dos campos, B3 e/ou turgência jugular	17%	Cautela com betabloqueador; diurético se congestão
III	Edema agudo de pulmão (estertores em mais da metade dos campos)	38%	VNI, nitrato IV, diurético; transferência prioritária
IV	Choque cardiogênico (hipotensão + hipoperfusão)	81%	Sem betabloqueador/nitrato; vasopressor; ICP urgente

As taxas históricas são pré-reperusão e servem para gradação relativa de gravidade, não como prognóstico atual.

2.2 Fatores de risco a registrar

Hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, história familiar de DAC precoce (homem <55 a, mulher <65 a), idade, obesidade, sedentarismo, DAC/ICP/CRM prévias, DRC, uso de cocaína (vasoespasma — evitar betabloqueador).

2.3 Diagnóstico diferencial que muda a conduta

Condição	Pistas clínicas	Por que importa
Dissecção aórtica	Dor lacerante, migratória para dorso; assimetria de pulsos/PA entre braços; sopro diastólico novo; mediastino alargado	Contraindica fibrinólise e anticoagulação. Aferir PA nos dois braços em todo paciente
Tromboembolismo pulmonar	Dispneia súbita desproporcional, hipoxemia, taquicardia, sinais de TVP, imobilização	Fibrinólise só por protocolo de TEP maciço; troponina pode elevar
Pneumotórax	Dor pleurítica súbita, MV abolido, timpanismo, jovem longilíneo/DPOC	Drenagem; RX/POCUS resolve
Pericardite	Dor que melhora inclinado à frente, atrito pericárdico, supra difuso côncavo com infra de PR	Fibrinolisar pericardite = hemopericárdio
Esofágica/GI	Relação com alimentação, pirose, disfagia	Diagnóstico de exclusão — nunca de primeira intenção

A Diretriz SBC 2025 incorpora escores para síndrome aórtica aguda e TEP e admite a estratégia de "descarte triplo" por angiotomografia (classe IIb, nível B) — **indisponível localmente**; suspeita de dissecção é critério de transferência imediata.

3. Exame físico — o que procurar

O exame é frequentemente normal e **não exclui SCA**. Sua função é estratificar gravidade e afastar diferenciais.

Achado	Interpretação
PA nos dois braços; pulsos periféricos	Assimetria >20 mmHg ou déficit de pulso: pensar dissecção
Hipotensão, extremidades frias/mosqueadas, oligúria, sonolência	Baixo débito / Killip IV
Estertores, B3, turgência jugular, hepatomegalia dolorosa	Congestão / Killip II-III
Turgência jugular + campos pulmonares limpos + hipotensão	IAM de ventrículo direito (pré-carga dependente) ou tamponamento
Sopro sistólico novo (apical ou paraesternal)	Insuficiência mitral isquêmica ou CIV — complicação mecânica
Atrito pericárdico	Pericardite (diferencial) ou pericardite pós-IAM
Sinais de TVP; MV assimétrico	TEP; pneumotórax

4. Propedêutica armada — o que esperar

4.1 ECG de 12 derivações em até 10 minutos da chegada (meta obrigatória)

- Um único ECG detecta menos de 50% dos IAM; **ECG seriado** (a cada 10-20 min se dor persistente e traçado não diagnóstico) eleva a sensibilidade para 70-90% (SBC 2025).
- **Supra de ST** no ponto J em 2 derivações contíguas: ≥ 1 mm na maioria das derivações; em V2-V3: $\geq 2,5$ mm (homem <40 a), ≥ 2 mm (homem ≥ 40 a), $\geq 1,5$ mm (mulher) — Quarta Definição Universal de IAM, 2018.
- **Derivações adicionais em todo IAM inferior (DII, DIII, aVF):** V3R-V4R (VD) e V7-V9 (parede posterior; suspeitar se infra de ST em V1-V3 — imagem em espelho). Nas derivações adicionais, $\geq 0,5$ mm já é significativo.
- **BRE novo ou presumivelmente novo** com clínica compatível = equivalente de supra.
- **CrITÉrios de Sgarbossa** (N Engl J Med 1996;334:481): supra concordante ≥ 1 mm (5 pts); infra concordante ≥ 1 mm em V1-V3 (3 pts); supra discordante ≥ 5 mm (2 pts). Escore ≥ 3 : especificidade $\sim 90-98\%$, sensibilidade baixa (20-36%). Sgarbossa modificado (Smith, 2012): razão ST/S $\leq -0,25$ substitui o terceiro critério e melhora a sensibilidade.
- Infra de ST difuso com supra em aVR: suspeitar lesão de tronco/multiarterial — transferência imediata mesmo sem supra clássico.

4.2 Troponina

- Biomarcador de escolha; CK-MB e mioglobina não são recomendadas para diagnóstico de rotina (SBC 2021/2025).
- **No IAMCSST não se aguarda troponina para reperfundir** — o diagnóstico é clínico + ECG.
- **Troponina ultrassensível:** algoritmos 0/1 h e 0/2 h (ESC/SBC 2025) com cortes específicos de cada ensaio, em ng/L — **[VERIFICAR com o laboratório do serviço quais cortes de exclusão/inclusão e delta se aplicam ao ensaio disponível]**. Com troponina convencional: admissão e 3-6 h (SBC 2021).
- Quarta Definição Universal (2018): infarto exige **curva** (ascensão e/ou queda com pelo menos um valor acima do percentil 99) + evidência de isquemia. Elevação estável sem curva = **lesão miocárdica** (DRC, IC, sepse, miocardite, TEP), não infarto.

4.3 Outros exames

Exame	O que esperar / para que serve
Glicemia capilar, eletrólitos (K, Mg), creatinina	Corrigir K/Mg antes de arritmias; creatinina define ajuste de enoxaparina (CICr <30) e contraste
Hemograma, coagulograma	Anemia (IAM tipo 2), plaquetas e TTPa/RNI antes de antitrombóticos
Perfil lipídico, HbA1c	Nas primeiras 24 h — orientam prevenção secundária
Radiografia de tórax	Congestão, mediastino alargado; não retardar perfusão
Ecocardiograma à beira-leito (POCUS)	Acinesia segmentar, VD dilatado, derrame, complicação mecânica, diferencial com dissecação/TEP

5. Fisiopatologia

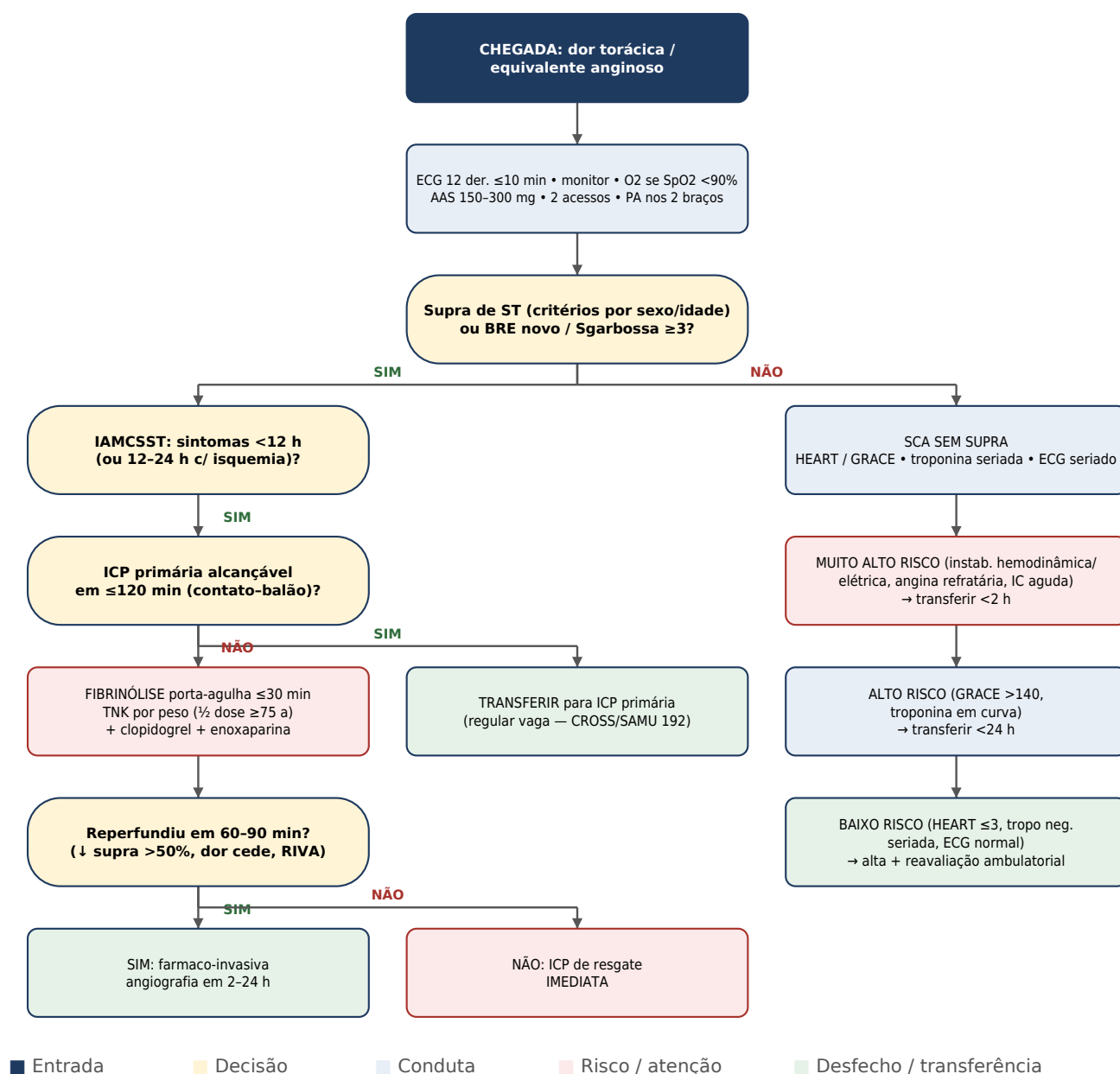
A maioria das SCA resulta de **ruptura ou erosão de placa aterosclerótica** coronariana com trombose sobreposta. A oclusão **total e persistente** gera necrose transmural com corrente de lesão orientada ao epicárdio — supradesnível de ST (IAMCSST). A oclusão **subtotal ou intermitente**, ou a embolização distal, gera isquemia subendocárdica — infra de ST/inversão de T (IAMSSST/angina instável). A necrose progride do subendocárdio ao epicárdio ao longo de horas, o que fundamenta a janela de perfusão (<12 h, benefício máximo nas primeiras 2-3 h). Complicações decorrem da perda de massa contrátil (choque), da instabilidade elétrica do miocárdio isquêmico (FV/TV, BAV) e da necrose de estruturas (músculo papilar, septo, parede livre).

Tipos de infarto — Quarta Definição Universal (2018)

Tipo	Mecanismo	Implicação no PS
1	Aterotrombose (ruptura/erosão de placa)	Reperusão / antitrombóticos — alvo deste protocolo
2	Desequilíbrio oferta/demanda (taquiarritmia, anemia, hipotensão, sepse, crise hipertensiva)	Tratar a causa; antitrombóticos e cateterismo não são automáticos
3	Morte súbita com isquemia antes de biomarcadores	—
4a / 4b / 4c	Relacionado a ICP / trombose de stent / reestenose	Trombose de stent = IAMCSST até prova em contrário — reperusão imediata
5	Relacionado a cirurgia de revascularização	—
MINOCA	Infarto sem obstrução $\geq 50\%$ (vasoespasmto, dissecação espontânea, embolia, microvascular)	Diagnóstico só após angiografia; conduta inicial idêntica

6. Fluxo de atendimento

Da chegada à saída. Contraindicação absoluta à fibrinólise desloca o paciente para o ramo "transferir para ICP" independentemente do tempo. Complicações (arritmia, choque, IAM de VD) são tratadas em paralelo — ver seção 8.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta	Fonte
Porta-ECG	≤10 min	SBC 2015/2025; ACC/AHA 2025; ESC 2023
Porta-agulha (fibrinólise)	≤30 min (ideal ≤10 min)	SBC 2015 = 30 min; ESC 2023 = 10 min (divergência declarada)
Primeiro contato-balão (quando transferido)	≤120 min (≤90 min em centro com hemodinâmica)	SBC 2015; ESC 2023; ACC/AHA 2025
Início dos sintomas-reperusão	<12 h (12–24 h se isquemia persistente/instabilidade)	SBC 2015
Angiografia após fibrinólise bem-sucedida	2–24 h (farmaco-invasiva)	SBC 2015; ESC 2023

6.2 Critérios de reperusão (avaliar 60–90 min após o bólus)

- Redução do supradesnível ≥50% na derivação de maior elevação;
- Alívio ou resolução da dor;
- Arritmias de reperusão (ritmo idioventricular acelerado — não tratar).
- Ausência dos critérios = falha → **ICP de resgate imediata**: acionar a regulação antes mesmo dos 90 min se piora clínica.

6.3 SCA sem supra — estratificação (SBC 2021)

Estrato	Critérios	Estratégia / tempo até angiografia
Muito alto risco	Instabilidade hemodinâmica ou elétrica, angina refratária, IC aguda, arritmia ventricular sustentada, parada ressuscitada, complicação mecânica	Invasiva imediata (<2 h) — transferir já
Alto risco	Curva de troponina compatível com IAM; alterações dinâmicas de ST/T; GRACE >140	Invasiva precoce (<24 h) — transferir no mesmo dia
Intermediário	DM, DRC, FEVE <40%, angina pós-IAM, ICP/CRM prévia, GRACE 109–140	Invasiva <72 h — discutir vaga com referência
Baixo risco	HEART ≤3, troponina seriada negativa, ECG sem isquemia, sem DAC prévia	Alta com reavaliação ambulatorial precoce e orientações de retorno

Escore HEART: História, ECG, Idade (Age), Fatores de Risco, Troponina — 0–2 pontos cada; baixo ≤3, intermediário 4–6, alto ≥7. A SBC recomenda o HEART pela praticidade; GRACE (idade, PAS, FC, creatinina, Killip, parada, desvio de ST, troponina) para prognóstico.

7. Tratamento — doses e vias

Regra de ouro no idoso ≥75 anos em fibrinólise: tenecteplase em **metade da dose**, clopidogrel **sem ataque** (75 mg) e enoxaparina **sem bólus IV** (0,75 mg/kg SC 12/12 h). Base: STREAM (N Engl J Med 2013;368:1379) — após a emenda de meia-dose, 0/97 hemorragias intracranianas vs 3/37 (8,1%) com dose plena; STREAM-2 (Circulation 2023;148:e1) consolidou o esquema.

7.1 Medidas gerais

Medida	Como	Observação
Oxigênio	Só se SpO ₂ <90% (ou desconforto respiratório)	Hiperóxia é deletéria — SBC 2015, ESC 2023, ACC/AHA 2025
Monitorização	ECG contínuo, oximetria, PA não invasiva; desfibrilador ao lado	Fase de maior risco de FV: primeiras horas
Acesso venoso	Dois acessos periféricos calibrosos	Evitar punções não compressíveis se fibrinólise prevista
Analgesia	Nitrato SL/IV primeiro; morfina 2–4 mg IV se dor refratária, repetir a cada 5–15 min	Morfina retarda absorção de antiplaquetários orais e mascara isquemia persistente — usar com parcimônia (ESC 2023/ACC 2025)
Nitrato	Dinitrato/mononitrato SL 5 mg até 3x; nitroglicerina IV 5–10 mcg/min titulando se dor persistente, HAS ou congestão	Contraindicado: PAS <90 mmHg ou queda >30 mmHg; IAM de VD; sildenafila <24 h / tadalafila <48 h

7.2 Antiplaquetários

Fármaco	Ataque	Manutenção	Quando / cautelas
AAS	150–300 mg mastigado (protocolos SUS/SBC: 200 mg)	75–100 mg/dia	Todos, na chegada. Contraindicação: alergia, sangramento ativo, úlcera ativa
Clopidogrel	300 mg se <75 a; 75 mg sem ataque se ≥75 a (fibrinólise). 600 mg se vai direto à ICP	75 mg/dia	Único P2Y12 com evidência na fibrinólise (SBC 2015)
Ticagrelor	180 mg	90 mg 12/12 h	Preferencial na estratégia invasiva; não usar com fibrinolítico ; cautela em BAV/asma grave/sangramento prévio
Prasugrel	60 mg	10 mg/dia	Só após anatomia (na hemodinâmica). Contraindicado: AVC/AIT prévio; evitar ≥75 a e <60 kg; não com fibrinólise

Nas SCA sem supra de muito alto risco encaminhadas a invasiva precoce, as diretrizes atuais (SBC 2021, ESC 2023) **não recomendam pré-tratamento rotineiro** com P2Y12 antes da anatomia — administrar AAS e anticoagular; discutir o P2Y12 com o centro receptor.

7.3 Anticoagulação

Fármaco	Esquema	Ajustes / cautelas
Enoxaparina (preferencial)	<75 a: 30 mg IV em bólus + 1 mg/kg SC 12/12 h (máx. 100 mg nas 2 primeiras doses). ≥75 a: sem bólus , 0,75 mg/kg SC 12/12 h (máx. 75 mg nas 2 primeiras)	ClCr <30 mL/min: 1 mg/kg SC 1x/dia. Nunca cruzar HNF ↔ enoxaparina. Manter até ICP ou 8 dias
Heparina não fracionada	60 UI/kg IV bólus (máx. 4.000 UI) + 12 UI/kg/h (máx. 1.000 UI/h), TTPa 1,5–2x em 3 h	Preferir se ClCr <15, peso extremo ou alta probabilidade de ICP em poucas horas
Fondaparinux	2,5 mg SC 1x/dia	Alternativa; contraindicado ClCr <20; exige HNF adicional na ICP. Disponibilidade local [VERIFICAR]

7.4 Fibrinolíticos

Fármaco	Dose	Observações
Tenecteplase (escolha)	Bólus IV único em 5–10 s por peso: <60 kg = 30 mg; 60–69 kg = 35 mg; 70–79 kg = 40 mg; 80–89 kg = 45 mg; ≥90 kg = 50 mg. ≥75 anos: metade da dose.	Financiada pelo MS para SAMU/PS (Portaria GM/MS 2.777/2014). Conferir peso real ou estimado; anotar horário do bólus
Alteplase (rt-PA)	Regime acelerado: 15 mg IV bólus + 0,75 mg/kg (máx. 50 mg) em 30 min + 0,5 mg/kg (máx. 35 mg) em 60 min (máx. total 100 mg)	Se tenecteplase indisponível; exige bomba de infusão
Estreptoquinase	1.500.000 UI IV em 30–60 min	Uso em declínio; hipotensão/alergia; não repetir entre 5 dias e 2 anos. Presença na RENAME vigente [VERIFICAR]

Contraindicações à fibrinólise (V Diretriz SBC 2015) — checklist antes do bólus

ABSOLUTAS (não fibrinolisar → transferir para ICP)	RELATIVAS (pesar risco-benefício; discutir com referência)
☐ Hemorragia intracraniana prévia (qualquer época) ☐ AVC isquêmico nos últimos 3 meses ☐ Neoplasia ou malformação vascular intracraniana ☐ Suspeita de dissecação aórtica ☐ Sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação) ☐ TCE ou trauma facial significativo nos últimos 3 meses ☐ Cirurgia intracraniana/espinal nos últimos 2 meses	☐ PA >180/110 mmHg não controlada na chegada ☐ Anticoagulação oral em uso ☐ Gestação ou puerpério <1 semana ☐ Úlcera péptica ativa ☐ RCP prolongada (>10 min) ou traumática ☐ Punção vascular não compressível ☐ Cirurgia de grande porte <3 semanas; sangramento interno <2-4 semanas ☐ Idade ≥75 a (usar meia-dose); AVC isquêmico >3 meses; demência

7.5 Terapia adjuvante nas primeiras 24 h

Fármaco	Esquema	Quando NÃO usar
Betabloqueador VO	Metoprolol 25-50 mg 12/12 h ou carvedilol 3,125-6,25 mg 12/12 h nas primeiras 24 h, se estável	FC <60, PAS <100, PR >240 ms, BAV 2º/3º, Killip ≥II, asma grave, cocaína, sinais de baixo débito, risco de choque (>70 a + PAS <120 + FC >110). Não usar IV de rotina
Estatina de alta intensidade	Atorvastatina 40-80 mg ou rosuvastatina 20-40 mg, primeira dose no PS	Hepatopatia ativa
IECA (ou BRA se intolerância)	Captopril 6,25-12,5 mg 8/8 h ou enalapril 2,5-5 mg 12/12 h, nas primeiras 24 h	PAS <100, K >5,5, creatinina >3 ou estenose bilateral de renais. Prioridade: IAM anterior, FEVE <40%, IC, DM, HAS
Antagonista mineralocorticoide	Espironolactona 25 mg/dia (FEVE ≤40% + IC ou DM)	K >5, ClCr <30 — geralmente iniciado no centro de referência

Doses de betabloqueador, IECA e estatina acima seguem a prática consagrada nas diretrizes SBC 2015/2021; as apresentações disponíveis no PS (REMUME/RENAME) devem ser conferidas **[VERIFICAR]**.

8. Como conduzir o caso — complicações, transferência e alta

8.1 Complicações — reconhecimento e primeira resposta

Situação	Reconhecer	Conduta imediata
FV / TV sem pulso	Colapso, ritmo chocável no monitor	Desfibrilação imediata (bifásico 120-200 J) + RCP conforme ACLS; amiodarona 300 mg IV após 3º choque
TV com pulso instável	Hipotensão, dor, rebaixamento	Cardioversão sincronizada 100 J; corrigir K/Mg
Bradicardia / BAV	FC <50 sintomática; BAV 2º Mobitz II ou 3º (comum no IAM inferior)	Atropina 0,5-1 mg IV (máx. 3 mg); marca-passo transcutâneo se refratário/instável; transferência prioritária
IAM de ventrículo direito	IAM inferior + hipotensão + jugulares túrgidas + pulmão limpo; supra em V4R	Expansão com SF 0,9% 250-500 mL em bólus, repetir guiado por resposta; evitar nitrato, morfina e diurético ; dobutamina se refratário
Choque cardiogênico (Killip IV)	PAS <90 sustentada + hipoperfusão	Noradrenalina como vasopressor inicial; dobutamina se baixo débito com PA aceitável; sem betabloqueador/nitrato ; ICP primária urgente independentemente do horário — fibrinólise só se transferência impossível
Edema agudo de pulmão (Killip III)	Dispneia, estertores difusos, SpO ₂ baixa	VNI (CPAP/BiPAP), nitroglicerina IV, furosemida 40-80 mg IV, sentar o paciente
Complicação mecânica	Sopro novo, choque súbito, EAP refratário, dissociação eletromecânica (ruptura de parede livre)	POCUS; suporte; transferência de emergência para centro com cirurgia cardíaca

8.2 Transferência e regulação

- **Quem:** todo IAMCSST (para ICP primária ou pós-fibrinólise); toda SCA sem supra de alto/muito alto risco; qualquer instabilidade ou complicação mecânica; suspeita de dissecação.
- **Quando:** muito alto risco/IAMCSST — imediata (acionar regulação **antes** de completar a estabilização); alto risco — mesmo dia (<24 h).
- **Como:** Unidade de Suporte Avançado (SAMU 192) com monitor/desfibrilador, dois acessos, oxigênio, material de via aérea, drogas de emergência; médico ou equipe habilitada conforme pactuação.
- **Documentação:** relatório com horários (início dos sintomas, chegada, ECG, bólus fibrinolítico, reavaliação), ECGs seriados anexos, medicações com dose/hora, checklist de contraindicações preenchido, peso, creatinina, alergias, contato do familiar.
- **Regulação:** CROSS-SP / Central de Regulação de Urgências. Hospital de referência com hemodinâmica: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026; habilitação SUS em cardiologia intervencionista a confirmar no CNES). Tempo de transporte estimado: _____ min [VERIFICAR].

8.3 Alta do PS (apenas SCA de baixo risco)

- Critérios: HEART ≤ 3 , duas troponinas negativas com intervalo adequado ao ensaio, ECG seriado sem isquemia, dor resolvida, sem DAC conhecida.
- Orientar retorno imediato se recorrência da dor; agendar reavaliação na APS/cardiologia em até 72 h com teste funcional; considerar AAS até a reavaliação se probabilidade intermediária.
- Registrar a decisão compartilhada e os sinais de alerta entregues por escrito.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
Tempo porta-ECG (mediana e % ≤ 10 min)	≤ 10 min em $\geq 90\%$ dos casos
Tempo porta-agulha	≤ 30 min em $\geq 75\%$ (ideal ≤ 10 min)
% de SCA com AAS na primeira hora	$\geq 95\%$
% de IAMCSST elegíveis efetivamente reperfundidos	100%
% de fibrinólises com checklist de contraindicações preenchido	100%
% de ≥ 75 anos com meia-dose de TNK e clopidogrel sem ataque	100%
Tempo entre decisão de transferir e saída da ambulância	Registrar e reduzir
Letalidade intra-PS e eventos hemorrágicos maiores	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Porta-agulha	SBC 2015: ≤ 30 min. ESC 2023: ≤ 10 min. Adotado ≤ 30 min como mínimo institucional, com meta interna de 10 min
Oxigênio	SBC 2015 admitia O ₂ nas primeiras horas; evidência posterior (AVOID, DETO2X) e ESC/ACC: só se SpO ₂ <90%. Adotada a restrição
Morfina	Recomendação clássica de uso liberal; diretrizes atuais restringem a dor refratária. Adotada a restrição
Tenecteplase ≥ 75 a	Meia-dose não consta na V Diretriz 2015 (anterior ao STREAM completo); adotada por evidência posterior (STREAM/STREAM-2, ESC 2023)
Troponina ultrasensível	Algoritmos 0/1 h e 0/2 h dependem do ensaio local — cortes numéricos [VERIFICAR]
Estreptoquinase / fondaparinux	Disponibilidade e presença na RENAME 2024 [VERIFICAR]
Rede regional	DRS XIV — São João da Boa Vista. Referência de hemodinâmica e fluxo formal [PACTUAR com SES-SP/CROSS]
Portaria MS	Portaria 2.994/2011 foi consolidada (PRC nº 3 e nº 6/2017) e atualizada pela Portaria 3.438/2021 — citar as vigentes

10. Referências

- Sociedade Brasileira de Cardiologia. V Diretriz da SBC sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. Arq Bras Cardiol 2015;105(2 Supl.1):1-121.
- Nicolau JC, Feitosa-Filho GS, Petriz JL, et al. Diretrizes da SBC sobre Angina Instável e IAM sem Supradesnível do Segmento ST – 2021. Arq Bras Cardiol 2021;117(1):181-264.
- de Barros e Silva PGM, Soeiro AM, Ornelas CE, et al. Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência – 2025. Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250620.
- Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. Circulation 2025;151:e771-e862.
- Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023;44(38):3720-3826.
- Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Circulation 2018;138:e618-e651.
- Killip T, Kimball JT. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. Am J Cardiol 1967;20(4):457-464.
- Sgarbossa EB, et al. N Engl J Med 1996;334(8):481-487. Smith SW, et al. Ann Emerg Med 2012;60(6):766-776.
- Armstrong PW, et al. (STREAM). N Engl J Med 2013;368(15):1379-1387. Van de Werf F, et al. (STREAM-2). Circulation 2023;148:753-764.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.438, de 7 de dezembro de 2021 (Linha de Cuidado do IAM); Portarias de Consolidação GM/MS nº 3 e nº 6/2017; Portaria GM/MS nº 2.777/2014 (tenecteplase — SAMU 192); RENAME 2024.
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole (edição vigente) — capítulo de síndromes coronarianas agudas.

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração